ЛП-№(002093)-(РГ-RU) от 25.06.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Велаксин, 75 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Велаксин, 150 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: венлафаксин.

Велаксин, 75 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Каждая капсула содержит 75 мг венлафаксина (в виде гидрохлорида).

Вещество, наличие которого надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий (см. раздел 4.4).

Велаксин, 150 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Каждая капсула содержит 150 мг венлафаксина (в виде гидрохлорида).

Вещество, наличие которого надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий (см. раздел 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Капсулы с пролонгированным высвобождением.

Велаксин, 75 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Твердые желатиновые капсулы размера «2», с бесцветным, прозрачным корпусом и крышечкой оранжево-коричневого цвета, содержащие смесь пеллет белого и желтого цвета, без или почти без запаха.

Велаксин, 150 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Твердые желатиновые капсулы «0EL», с бесцветным, прозрачным корпусом и крышечкой оранжево-коричневого цвета, содержащие смесь пеллет белого и желтого цвета, без или почти без запаха.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1 Показания к применению

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Препарат Велаксин показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет для:

- лечения депрессии, профилактика рецидивов;
- лечения генерализованных тревожных расстройств;
- лечения социальных тревожных расстройств;
- лечения панических расстройств, сопровождающихся или нет агорафобией.

4.2 Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Депрессия

Рекомендуемая начальная доза - 75 мг 1 раз в день.

Если по мнению врача, необходима более высокая доза препарата (тяжелое депрессивное расстройство или другие состояния, требующие стационарного лечения), можно сразу назначить 150 мг 1 раз в день. Впоследствии суточную дозу можно увеличивать на 75 мг с интервалом две недели или больше (но не чаще, чем через 4 дня) до достижения желаемого терапевтического эффекта.

Максимальная суточная доза - 375 мг.

После достижения необходимого терапевтического эффекта суточная доза может быть постепенно снижена до минимального эффективного уровня.

Поддерживающая терапия и профилактика рецидивов

Лечение депрессии должно продолжаться не менее 6 месяцев. При стабилизирующей терапии, а также терапии с целью профилактики рецидивов или новых эпизодов депрессии, обычно используются дозы, продемонстрировавшие свою эффективность. Врач должен регулярно (не менее 1 раза в 3 месяца) контролировать эффективность длительной терапии препаратом Велаксин.

Генерализованные тревожные расстройства

Рекомендованная начальная доза венлафаксина с пролонгированным высвобождением - 75 мг 1 раз в сутки. Пациентам, у которых начальная доза 75 мг/сутки не оказывает терапевтического действия, для получения пользы от препарата дозу можно увеличить до максимальной - 225 мг/сутки. Увеличивать дозу можно с интервалами в 2 недели или более.

В связи с риском дозозависимых неблагоприятных эффектов увеличивать ее следует только после клинической оценки. Необходимо сохранять минимальную эффективную дозу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Лечение пациентов должно продолжаться достаточное время, как правило, несколько месяцев или дольше. Необходимо регулярно проводить оценку лечения индивидуально в каждом случае.

Социальные тревожные расстройства

Рекомендованная доза венлафаксина с пролонгированным высвобождением - 75 мг 1 раз в сутки. Не доказано, что более высокие дозы обеспечивают дополнительную пользу.

Тем не менее, отдельным пациентам, у которых начальная доза 75 мг/сутки не оказывает терапевтического действия, следует рассмотреть возможность увеличения дозы до максимальной - 225 мг/сутки. Увеличивать дозу можно с интервалами в 2 недели или более.

В связи с риском дозозависимых неблагоприятных эффектов увеличивать ее следует только после клинической оценки. Необходимо сохранять минимальную эффективную дозу.

Лечение пациентов должно продолжаться достаточное время, как правило, несколько месяцев или дольше. Необходимо регулярно проводить оценку лечения индивидуально в каждом случае.

Панические расстройства

Рекомендуется принимать венлафаксин с пролонгированным высвобождением в течение 7 дней в дозе 37,5 мг/сутки. Затем дозу следует увеличить до 75 мг/сутки. Пациентам, у которых доза 75 мг/сутки не оказывает терапевтического действия, для получения пользы от препарата дозу можно увеличить до максимальной - 225 мг/сутки. Увеличивать дозу можно с интервалами в 2 недели или более.

В связи с риском дозозависимых неблагоприятных эффектов увеличивать ее следует только после клинической оценки. Необходимо сохранять минимальную эффективную дозу.

Лечение пациентов должно продолжаться достаточное время, как правило, несколько месяцев или дольше. Необходимо регулярно проводить оценку лечения индивидуально в каждом случае.

Перевод пациентов с таблеток венлафаксина на прием препарата в капсулах с пролонгированным высвобождением

Пациентов, принимающих венлафаксин в лекарственной форме таблетки, можно перевести на прием препарата в лекарственной форме капсулы с пролонгированным

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

высвобождением с назначением эквивалентной дозы 1 раз в сутки. Однако может потребоваться индивидуальная корректировка дозы.

Особые группы пациентов

Пациенты с почечной недостаточностью

При легкой почечной недостаточности (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) более 30 мл/мин) коррекция режима дозирования не требуется. При умеренной почечной недостаточности (СКФ 10-—30 мл/мин) дозу следует снизить на 50%. В связи с удлинением периода полувыведения ($T_{½}$) венлафаксина и его активного метаболита О-десметилвенлафаксин (ОДВ), таким пациентам следует принимать всю дозу 1 раз в день. Не рекомендуется применять венлафаксин при тяжелой почечной недостаточности (СКФ менее 10 мл/мин), поскольку надежные данные о такой терапии отсутствуют. Пациенты на гемодиализе могут получать 50% обычной суточной дозы венлафаксина после завершения гемодиализа.

Пациенты с печеночной недостаточностью

У пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью обычно следует рассмотреть возможность снижения дозы на 50%. Не рекомендуется применять венлафаксин при тяжелой печеночной недостаточности, поскольку надежные данные о такой терапии отсутствуют.

Лица пожилого возраста

Сам по себе пожилой возраст пациента не требует изменения дозы, однако (как и при назначении других лекарственных препаратов) при лечении пожилых пациентов требуется осторожность, например, в связи с возможностью нарушения функции почек. Следует применять наименьшую эффективную дозу. При повышении дозы пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением.

Дети

Безопасность и эффективность применения венлафаксина у детей и подростков моложе 18 лет не установлена.

Синдром отмены, наблюдаемый при прекращении лечения венлафаксином

Следует избегать резкой отмены препарата. При прекращении лечения дозу венлафаксина следует постепенно снижать в течение не менее 1–2 недель, чтобы уменьшить риск развития синдрома «отмены» (см. разделы 4.4. и 4.8.). Поэтому перед полной отменой препарата рекомендуется постепенное снижение дозы. Длительность периода, необходимого для постепенного снижения дозы, зависит от величины дозы,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

продолжительности терапии и индивидуальной чувствительности пациента. Некоторым пациентам может потребоваться более постепенное снижение дозы, в течение нескольких месяцев или более. Если после снижения дозы или прекращения лечения развиваются выраженные симптомы синдрома «отмены», можно рассмотреть возможность продолжения лечения в ранее назначенной дозе. Впоследствии можно продолжить снижение дозы, но более постепенно.

Способ применения

Препарат Велаксин, капсулы с пролонгированным высвобождением, следует принимать внутрь, во время еды. Каждую капсулу следует проглатывать целиком и запивать жидкостью. Капсулы нельзя делить, измельчать, жевать или помещать в воду. Суточную дозу следует принимать за 1 прием (утром или вечером) каждый раз приблизительно в одно и то же время.

4.3 Противопоказания

- Гиперчувствительность, к венлафаксину или, любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
- Одновременный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) (см. раздел 4.5.);
- Тяжелые нарушения функции почек и/или печени (СКФ <10 мл/мин, ПВ >18 секунд);
- Возраст до 18 лет (безопасность и эффективность для этой возрастной группы не доказаны);
- Беременность или предполагаемая беременность;
- Период лактации (нет достаточных данных контролируемых исследований).

4.4 Особые указания и меры предосторожности при применении

С осторожностью

Недавно перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность (СН), заболевания коронарных артерий, изменения на электрокардиограмме (ЭКГ), в том числе удлинение интервала QT, нарушения электролитного баланса, артериальная гипертензия (АГ), тахикардия, судороги в анамнезе, повышение внутриглазного давления, закрытоугольная глаукома,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

маниакальные состояния в анамнезе, предрасположенность к кровотечениям со стороны кожных покровов и слизистых оболочек, исходно сниженная масса тела.

Особые указания

Передозировка

Пациентам следует рекомендовать не употреблять алкоголь, учитывая его влияние на центральную нервную систему (ЦНС) и возможность клинического ухудшения психических расстройств, а также возможность неблагоприятного взаимодействия с венлафаксином, включая угнетающее действие на ЦНС (раздел 4.5). В пострегистрационном периоде наиболее часто зарегистрированы случаи передозировки венлафаксином преимущественно в комбинации с алкоголем и/или другими лекарственными препаратами, включая случаи с летальным исходом (раздел 4.9).

Для снижения риска передозировки венлафаксин следует выписывать в минимальном количестве в одном рецепте, в соответствии с планом ведения пациента (см. раздел 4.9).

Суицид/суицидальные мысли или клиническое усугубление

Следует помнить о риске суицидальных попыток при лечении пациентов с депрессиями.

Депрессия связана с повышенным риском суицидальных мыслей, нанесения себе увечий и суицида (суицидальных действий). Данный риск сохраняется вплоть до полной ремиссии. В первые несколько недель после начала лечения улучшение может отсутствовать, и необходимо тщательно контролировать пациентов вплоть до наступления такого улучшения. Клинический опыт показывает, что на ранних стадиях выздоровления нередко возрастает риск суицида.

Другие психические расстройства, при которых показано применение венлафаксина, также могут быть связаны с повышенным риском суицидальных действий и проявлений. Кроме того, данные состояния могут протекать на фоне большого депрессивного расстройства. Таким образом, при лечении пациентов с другими психическими расстройствами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при лечении большого депрессивного расстройства.

Пациенты с наличием явлений, связанных с суицидом в анамнезе, или пациенты с выраженными суицидальными наклонностями до начала лечения подвержены более высокому риску появления суицидальных мыслей или суицидальных попыток, поэтому нуждаются в тщательном контроле во время лечения венлафаксином. Мета-анализ

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

плацебо-контролируемых клинических исследований антидепрессантов у взрослых пациентов с психическими расстройствами установил повышенный риск суицидального поведения на фоне применения антидепрессантов по сравнению с плацебо у пациентов моложе 25 лет.

Необходимо установить тщательное наблюдение за пациентами, получающими лечение венлафаксином, в особенности подверженных высокому риску, преимущественно в начале лечения или после изменения дозировки. Пациенты (и их попечители) должны быть предупреждены о необходимости контролировать признаки клинического ухудшения, суицидального поведения и необычных изменений поведения и обращаться за медицинской помощью сразу же после появления подобных симптомов.

Для уменьшения риска передозировки препарата Велаксин лечение необходимо начинать с минимально возможной дозы.

Дети

Препарат Велаксин не следует применять у детей и подростков моложе 18 лет. Суицидальное поведение (попытки суицида и суицидальные мысли) и враждебность (главным образом агрессивность, оппозиционное поведение и раздражение) наблюдались наиболее часто в ходе клинических исследований у детей и подростков, получавших антидепрессанты, в сравнении с теми, кто получал плацебо. Если по клиническим показаниям принимается решение о назначении препарата, пациент должен находиться под строгим контролем на предмет возникновения суицидальных симптомов. Кроме того, данные о долгосрочной безопасности у детей и подростков в отношении роста, созревания, когнитивного и поведенческого развития отсутствуют.

Серотониновый синдром

Как и при приеме других серотонинергических препаратов, возможно развитие потенциально угрожающего жизни состояния - серотонинового синдрома или реакций, подобных злокачественному нейролептическому синдрому (ЗНС), на фоне лечения венлафаксином, в особенности при одновременном применении других серотонинергических препаратов (в том числе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН), триптанов, трициклических антидепрессантов, амфетаминов, препаратов лития, сибутрамина, препаратов зверобоя продырявленного, опиоидов, [например бупренорфина (или его комбинации с налоксоном), фентанила и его аналогов, трамадола, декстрометорфана, тапентадола, петидина, метадона и пентазоцина] вместе

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

с препаратами, нарушающими метаболизм серотонина, например, ингибиторами МАО (включая метиленовый синий), предшественниками серотонина (такими как пищевые добавки триптофана) или нейролептиками и другими антагонистами дофамина (см. разделы 4.3. и 4.5.).

Симптомы серотонинового синдрома включают изменения психического состояния (ажитация, галлюцинации, кома), расстройства вегетативной нервной системы (тахикардия, нестабильное артериальное давление (АД), гипертермия), нервно-мышечные нарушения (гиперрефлексия, дискоординация) и/или желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея).

При подозрении на серотониновый синдром следует рассмотреть целесообразность снижения дозы или прекращения лечения - в зависимости от тяжести симптомов.

Серотониновый синдром в самой тяжелой форме может быть схож с ЗНС, включая гипертермию, ригидность мышц, расстройства вегетативной нервной системы с потенциальными быстрыми изменениями в показателях жизненно важных функций и изменениями психического состояния.

При наличии клинических показаний к одновременному применению венлафаксина и других лекарственных препаратов, влияющих на серотонинергические и/или дофаминергические нейротрансмиттерные системы, необходимо тщательно контролировать состояние пациента, особенно в начале лечения и при повышении дозы.

При подозрении на развитие серотонинового синдрома следует рассмотреть вопрос о снижении дозы препарата или отмене лечения в зависимости от тяжести симптомов.

Одновременное применение венлафаксина с предшественниками серотонина (например, пищевыми добавками триптофана) не рекомендуется.

У небольшого количества пациентов с эмоциональной лабильностью при применении венлафаксина отмечались случаи мании/гипомании. Как и другие антидепрессанты, препарат Велаксин следует с осторожностью применять у пациентов с манией в анамнезе.

Судороги развиваются очень редко. Особое внимание следует уделять пациентам с эпилепсией или синдромом органического поражения головного мозга. При необходимости требуется наблюдение невролога. Осторожность необходима и при одновременном назначении препарата Велаксин и *электросудорожной* терапии.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

У пациентов с циррозом печени, с нарушениями функции почек средней и тяжелой степени тяжести почечный клиренс венлафаксина и его активных метаболитов снижен и удлинен $T_{1/2}$ препарата из плазмы крови. У таких пациентов препарат Велаксин применяют с осторожностью в меньших дозах или с увеличенными интервалами между приемом.

На фоне лечения антидепрессантами, в том числе из группы СИОЗС, изредка может развиваться гипонатриемия. Следует уделять повышенное внимание пациентам пожилого возраста, пациентам, принимающим диуретики, или с признаками обезвоживания. При приеме венлафаксина отмечены редкие случаи гипонатриемии, особенно у пациентов пожилого возраста; состояние пациентов улучшалось после отмены препарата.

В следующих случаях необходим регулярный контроль состояния пациентов:

- при нарушениях мочеиспускания (например, при гипертрофии простаты);
- при закрытоугольной глаукоме;
- при повышенном или низком АД;
- при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как нарушения проводимости, стенокардия напряжения и недавно перенесенный ИМ.

Закрытоугольная глаукома

Возможно возникновение мидриаза на фоне применения венлафаксина. Рекомендован тщательный контроль пациентов с повышенным внутриглазным давлением или пациентов, подверженных риску развития закрытоугольной глаукомы.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении нескольких лекарственных препаратов.

У некоторых пациентов терапия венлафаксином сопровождается повышением АД, которое может сохраняться при длительном приеме препарата. У пациентов, недавно перенесших ИМ, инсульт, страдающих сахарным диабетом, необходим строгий контроль АД во время лечения венлафаксином. Контроль АД рекомендуется проводить у каждого пациента, принимающего венлафаксин. При повышении диастолического АД выше 100 мм рт. ст. необходимо прекратить прием венлафаксина.

В пострегистрационном периоде применения сообщалось о случаях удлинения интервала QTc, желудочковой тахикардии типа «пируэт», желудочковой тахикардии, сердечной аритмии со смертельным исходом на фоне применения венлафаксина,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

особенно в случае передозировки или у пациентов с другими факторами риска удлинения интервала QTc/желудочковой тахикардии типа «пируэт». Следует оценивать соотношение «польза - риск» перед назначением венлафаксина пациентам с высоким риском тяжелой сердечной аритмии или удлинения интервала QTc.

При применении венлафаксина, особенно в высоких дозах, может повышаться частота сердечных сокращений (ЧСС). Необходимо соблюдать осторожность при применении венлафаксина у пациентов с тахиаритмиями.

При необходимости длительной терапии венлафаксином необходимо регулярно контролировать концентрацию холестерина в плазме крови. При развитии гиперхолестеринемии следует решить вопрос о необходимости продолжения терапии препаратом Велаксин или о замене его другим антидепрессантом.

При лечении депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза может развиться переход в маниакальное состояние, который требует быстрой оценки состояния пациента и проводимой терапии.

С осторожностью венлафаксин назначается пациентам, недавно перенесшим ИМ, и/или с нестабильной стенокардией и АГ.

Эффективность и безопасность венлафаксина при одновременном применении с препаратами для снижения массы тела, включая фентермин, не изучались. Одновременное применение венлафаксина с такими препаратами не рекомендуется. Венлафаксин не показан для снижения массы тела как самостоятельно, так и в комбинации с другими лекарственными препаратами.

Гипонатриемия

При приеме венлафаксина возможны случаи гипонатриемии и/или синдрома нарушения секреции антидиуретического гормона. Это явление наиболее часто наблюдалось у пациентов с гиповолемией или обезвоживанием. Большему риску в отношении данного явления подвержены пожилые пациенты, пациенты, принимающие диуретики, и пациенты с повышенным риском развития гиповолемии.

Патологическое кровотечение

Лекарственные препараты, ингибирующие захват серотонина, могут приводить к снижению функции тромбоцитов. Кровотечения на фоне применения СИОЗС и СИОЗСН варьировались от экхимозов, гематом, носовых кровотечений, петехий до желудочно-кишечных кровотечений и угрожающих жизни кровотечений. Риск развития

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

кровотечений может быть повышен у пациентов, получающих венлафаксин. Как и другие ингибиторы обратного захвата серотонина, венлафаксин следует применять с осторожностью у пациентов, предрасположенных к кровотечениям, в том числе у пациентов, получающих антикоагулянты и ингибиторы агрегации тромбоцитов.

Риск послеродового кровотечения

Препараты СИОЗС/СИОЗСН могут повышать риск развития послеродового кровотечения (см. разделы 4.6. и 4.8.).

Агрессивное поведение

Агрессивное поведение возможно у небольшого числа пациентов, применяющих антидепрессанты, включая венлафаксин. Данный симптом отмечался после начала лечения, при изменении дозировки и после прекращения лечения.

Подобно другим антидепрессантам, венлафаксин следует применять с осторожностью у пациентов с агрессивным поведением в анамнезе.

Синдром «отмены»

Хорошо известно, что при прекращении приема антидепрессантов возникают симптомы синдрома «отмены», иногда эти симптомы могут быть длительными и тяжелыми. Суицидальное поведение/суицидальные мысли и агрессия наблюдались у пациентов при изменении режима дозирования венлафаксина, а также при его отмене. В связи с этим пациенты должны находиться под тщательным медицинским наблюдением при снижении дозы или в период отмены препарата (см. 4.4, подразделы *Суицид/суицидальные мысли или клиническое усугубление* и *Агрессивное поведение*).

Синдром «отмены» при прекращении терапии встречается достаточно часто, особенно если лечение было прервано внезапно (см. раздел 4.8.). В ходе клинических исследований нежелательные явления, отмечавшиеся после прекращения лечения (при снижении дозы и после снижения дозы) отмечались примерно у 31% пациентов, принимавших венлафаксин, и у 17% пациентов, получавших плацебо.

Риск развития синдрома «отмены» может зависеть от нескольких факторов, включая длительность лечения и дозировку препарата, а также скорость снижения дозы. Головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезию), нарушение сна (в том числе бессонница и интенсивные сновидения), возбуждение или беспокойство, тошнота и/или рвота, тремор, головная боль, нарушение зрения и артериальная гипертензия являются самыми распространенными нежелательными реакциями. В целом данные

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

симптомы носят легкий или умеренный характер, однако у некоторых пациентов они могут быть серьезными.

Данные симптомы, как правило, развиваются в течение первых нескольких дней после прекращения лечения, однако в редких случаях сообщалось о развитии подобных симптомов у пациентов, случайно пропустивших прием очередной дозы. В целом данные симптомы проходят самостоятельно в течение 2 недель, хотя у некоторых пациентов они могут сохраняться в течение более длительного срока (2-3 месяца и дольше). Таким образом, при необходимости прекращения лечения рекомендуется постепенное снижение дозы венлафаксина в течение нескольких недель или месяцев в зависимости от состояния пациента (см. раздел 4.2.).

У некоторых пациентов отмена препарата может занять несколько месяцев или дольше.

Акатизия/психомоторное возбуждение

Применение венлафаксина было связано с развитием акатизии, характеризующейся субъективно неприятным или тревожным двигательным беспокойством и необходимостью двигаться на фоне невозможности сидеть или спокойно стоять. Такое явление чаще всего развивается в течение первых нескольких недель от начала лечения. У пациентов с подобными симптомами повышение дозы препарата Велаксин может привести к неблагоприятным последствиям.

Сексуальная дисфункция

СИОЗСН могут вызывать симптомы сексуальной дисфункции. Сообщалось о длительной сексуальной дисфункции, симптомы которой сохранялись и после прекращения приема СИОЗСН.

Сухость слизистой оболочки полости рта

Сухость слизистой оболочки полости рта отмечалась у 10% пациентов, получавших венлафаксин. Это может увеличивать риск развития кариеса, поэтому пациенты должны уделять особое внимание гигиене полости рта.

Сахарный диабет

У пациентов с сахарным диабетом применение СИОЗС или венлафаксина может приводить к изменению гликемического контроля. Может потребоваться коррекция дозы инсулина и/или гипогликемических препаратов для приема внутрь.

Влияние венлафаксина на результаты лабораторных исследований

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

У пациентов, применявших венлафаксин, отмечались ложноположительные результаты иммуноферментного анализа мочи на фенциклидин и амфетамины. Такой эффект объясняется отсутствием специфичности данных лабораторных исследований. Ложноотрицательные результаты могут быть получены в течение нескольких дней после прекращения применения венлафаксина. Контрольные лабораторные исследования, например, газовая хроматография или масс-спектрометрия позволяют отличить венлафаксин от фенциклидина и амфетамина.

При появлении кожной сыпи, крапивницы или других аллергических реакций необходимо прекратить терапию препаратом Велаксин.

Во время лечения препаратом Велаксин рекомендуется воздерживаться от приема алкоголя.

Вспомогательные вещества

Натрий

Каждая капсула препарата Велаксин 75 мг содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия, то есть практически не содержит натрия.

Каждая капсула препарата Велаксин 150 мг содержит 36 мг натрия, что соответствует 1,8% от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей.

4.5 Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Необратимые неизбирательные ингибиторы МАО

Препарат Велаксин нельзя принимать одновременно с *ингибиторами МАО* или в течение 14 дней после их отмены. Перед началом приема ингибиторов МАО после отмены препарата Велаксин должно пройти не менее 7 дней.

Обратимый избирательный ингибитор МАО-А (моклобемид)

Ввиду риска развития серотонинового синдрома не рекомендуется совместное применение венлафаксина и обратимых избирательных ИМАО, таких как моклобемид. Перерыв между началом лечения венлафаксином и предшествующим лечением обратимым ингибитором МАО может быть меньше 14 дней. Рекомендуется прекратить прием венлафаксина не менее чем за 7 дней до начала лечения обратимыми ИМАО (см. 4.4).

Обратимый, неизбирательный ингибитор МАО (линезолид)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Антибиотик линезолид является слабым обратимым и неселективным ингибитором МАО, и его не следует применять пациентам, получающим лечение венлафаксином.

У пациентов, недавно прекративших применение ингибитора МАО и начавших применение венлафаксина либо недавно прекративших лечение венлафаксином до начала применения ингибитора МАО, отмечались тяжелые побочные реакции. Такие реакции включали тремор, миоклонические судороги, диафорез, тошноту, рвоту, «приливы», головокружение и гипертермию с симптомами, характерными для ЗНС, судороги и летальный исход.

Венлафаксин не оказывает влияния на фармакокинетику *лития.* Однако, возможно развитие серотонинового синдрома при совместном применении венлафаксина и лития.

Фармакокинетические параметры венлафаксина и ОДВ не изменялись при одновременном применении *диазепама.* Венлафаксин не влияет на психомоторные или психометрические эффекты диазепама.

Одновременный прием внутрь *галоперидола* при равновесном состоянии венлафаксина приводил к снижению общего почечного клиренса галоперидола, повышению его площади под фармакокинетической кривой «концентрация-время» (AUC) и максимальной концентрации в плазме крови (C_{max}). $T_{½}$ галоперидола оставался без изменений. Механизм этого взаимодействия неизвестен.

Венлафаксин не изменял метаболизм *имипрамина* и его метаболита 2-ОН-имипрамина, несмотря на снижение почечного клиренса 2-гидроксидезипрамина и повышение AUC и C_{max} дезипрамина в плазме крови примерно на 35%.

Циметидин подавлял метаболизм венлафаксина при «первичном прохождении» через печень, но не оказывал значимого влияния на образование или выведение ОДВ, который циркулирует в плазме крови в значительно больших количествах. Поэтому при одновременном применении циметидина и препарата Велаксин не требуется изменения доз. У пациентов с нарушением функции печени и у пациентов пожилого возраста это взаимодействие может быть более выраженным, поэтому им необходимо оставаться под наблюдением при одновременном приеме этих препаратов.

Серотониновый синдром

Как и при приеме других серотонинергических препаратов, на фоне лечения венлафаксином возможно развитие потенциально угрожающего жизни состояния - серотонинового синдрома, прежде всего, при одновременном применении других

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

препаратов, влияющих на систему серотонинергических нейротрансмиттеров (в том числе триптанов, СИОЗС, СИОЗСН, трициклических антидепрессантов, амфетаминов, лития, сибутрамина, препаратов зверобоя продырявленного, опиоидов [фентанила и его производных, бупренорфина (или его комбинации с налоксоном), трамадола, декстрометорфана, тапентадола, петидина, метадона и пентазоцина], лекарственных препаратов, нарушающих метаболизм серотонина (например, ингибиторов МАО, включая метиленовый синий) или других предшественников серотонина (таких как пищевые добавки триптофана), или нейролептиков, или других антагонистов дофамина (см. разделы 4.3 и 4.4).

Если имеются клинические показания к одновременному применению венлафаксина и препарата, влияющего на серотонинергическую и/или дофаминергеческую систему, необходимо тщательно контролировать состояние пациента, в особенности в начале лечения и при повышении дозы препарата Велаксин. Одновременное применение венлафаксина с предшественниками серотонина (например, пищевыми добавками триптофана) не рекомендуется.

Препараты, воздействующие на ЦНС

Риск применения венлафаксина в комбинации с другими препаратами, воздействующими на ЦНС, не был систематически оценен. Таким образом, следует соблюдать осторожность при одновременном применении венлафаксина с другими препаратами, воздействующими на ЦНС.

Этанол

Пациентам следует рекомендовать не употреблять алкоголь учитывая его влияние на ЦНС и возможность клинического ухудшения психического состояния, а также возможное неблагоприятное взаимодействие с венлафаксином, включая угнетающее действие на ЦНС.

Препараты, удлиняющие интервал QT

Риск удлинения QTc и/или развития желудочковой аритмии (например, желудочковой тахикардии типа «пируэт») повышается при одновременном применении других лекарственных препаратов, удлиняющих интервал QTc. Одновременного применения таких препаратов следует избегать (см. раздел 4.4.).

Лекарственные препараты, удлиняющие интервал QTc:

- антиаритмические препараты классов IA и III (хинидин, амиодарон, соталол, дофетилид);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

- некоторые нейролептики (например, тиоридазин);
- некоторые макролиды (например, эритромицин);
- некоторые антигистаминные препараты;
- некоторые хинолоны (например, моксифлоксацин).

Вышеперечисленный список не является исчерпывающим, поэтому одновременное применение других отдельных лекарственных препаратов, значимо удлиняющих интервал QT, следует также избегать.

При применении венлафаксина пациентами, принимающими *варфарин,* отмечалось удлинение ПВ и частичного тромбопластинового времени.

При одновременном применении с *рисперидоном* фармакокинетика венлафаксина существенно не изменялась.

Венлафаксин преимущественно метаболизируется в печени изоферментом CYP2D6 с образованием ОДВ и изоферментом CYP3A3/4 - до N-десметилвенлафаксина. Нельзя исключить потенциального взаимодействия между венлафаксином и *препаратами, подавляющими активность изофермента CYP2D6.* Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата Велаксин с этими препаратами (например, хинидин, пароксетин, флуоксетин, флувоксамин, перфеназин, галоперидол, левомепромазин).

При применении венлафаксина следует помнить о полиморфизме изофермента CYP2D6. У пациентов с медленным метаболизмом изофермента CYP2D6 (около 7% европейского населения) следует ожидать более высоких концентраций венлафаксина в плазме крови.

Повышенные сывороточные концентрации венлафаксина также могут наблюдаться при одновременном применении *ингибиторов изофермента CYP3A3/4* (например, *атазанавир, нелфинавир, ритонавир, индинавир, саквинавир, итраконазол, вориконазол, позаконазол, кетоконазол, кларитромицин, эритромицин, телитромицин, верапамил и циметидин).* Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность, если лечение пациента включает совместное применение ингибитора CYP3A4 и венлафаксина.

Венлафаксин - относительно слабый ингибитор изофермента CYP2D6, не подавляет активность изоферментов CYP1A2, CYP2C9 или CYP3A4.

Метопролол

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Одновременное применение венлафаксина и метопролола у здоровых добровольцев в исследовании фармакокинетического взаимодействия обоих лекарственных препаратов приводило к увеличению концентрации метопролола в плазме крови примерно на 30–40% без изменения концентрации в плазме крови его активного метаболита, а-гидроксиметопролола. Клиническая значимость таких результатов у пациентов с АГ не установлена. Метопролол не изменял фармакокинетический профиль венлафаксина и его активного метаболита ОДВ. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении венлафаксина и метопролола.

Индинавир

По результатам фармакокинетического исследования взаимодействия венлафаксина и индинавира отмечено снижение AUC и C_{max} индинавира в плазме крови на 28% и 36% соответственно. Индинавир не оказывал влияния на фармакокинетику венлафаксина и ОДВ. Клиническая значимость данного взаимодействия неизвестна.

Контрацептивы для приема внутрь

В ходе пострегистрационных исследований сообщалось о случаях незапланированной беременности у пациенток, принимавших контрацептивы для приема внутрь, на фоне лечения венлафаксином. Отсутствовали четкие данные, подтверждающие возникновение беременности в результате лекарственного взаимодействия контрацептивов для приема внутрь с венлафаксином. Исследование взаимодействия с гормональными контрацептивами не проводилось.

4.6 Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Безопасность применения венлафаксина при беременности не доказана, поэтому применение во время беременности (или предполагаемой беременности) возможно только в том случае, если потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода. Женщины детородного возраста должны быть предупреждены об этом до начала лечения и должны немедленно обратиться к врачу в случае наступления беременности или планирования беременности в период лечения препаратом.

Как и в случае с другими ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС/СИОЗСН), у новорожденных могут наблюдаться симптомы отмены, если венлафаксин принимался до самых родов или незадолго до этого. У некоторых новорожденных, подвергшихся воздействию венлафаксина в конце третьего триместра,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

развиваются осложнения, требующие зондового кормления, вспомогательной искусственной вентиляции легких или продолжительной госпитализации. Такие осложнения могут возникнуть непосредственно после родов.

Согласно эпидемиологическим данным, применение СИОЗС при беременности, особенно в конце беременности, может повысить риск персистирующей легочной гипертензии новорожденных. Хотя исследований по изучению связи легочной гипертензии и лечения СИОЗСН не проводилось, принимая во внимание схожий механизм действия (угнетение обратного захвата серотонина), нельзя не учитывать этот потенциальный риск при назначении венлафаксина.

Следующие симптомы могут наблюдаться у новорожденных, если мать принимала СИОЗС/СИОЗСН в конце беременности: раздражимость, тремор, гипотония, постоянный плач, а также проблемы с сосанием или сном.

Причиной этих симптомов могут быть серотонинергическое действие или симптомы лекарственной экспозиции. В большинстве случаев эти осложнения наблюдаются непосредственно после или в течение 24 часов после родов.

Данные наблюдений указывают на повышенный риск (менее чем в 2 раза) развития послеродового кровотечения после приема СИОЗС/ СИОЗСН в течение месяца до родов (см. разделы 4.4, 4.8.).

Лактация

Венлафаксин и его метаболит (ОДВ) выделяются в грудное молоко. Безопасность этих веществ для новорожденных детей не доказана, поэтому прием венлафаксина во время грудного вскармливания не рекомендуется.

В пострегистрационном периоде у детей, находившихся на грудном вскармливании, наблюдались раздражимость, плач и нарушения сна. Нельзя исключать такой риск для ребенка, находящегося на грудном вскармливании. Также сообщалось о развитии симптомов, соответствующих синдрому «отмены» венлафаксина, после прекращения грудного вскармливания.

При необходимости приема препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Если лечение матери было завершено незадолго до родов, у новорожденного могут возникнуть симптомы отмены препарата.

Фертильность

Данные отсутствуют.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

4.7 Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат оказывает влияние на психофизические способности. Также он может ослаблять реакции у некоторых пациентов. Это следует учитывать при управлении транспортными средствами, механизмами и выполнении задач, требующих повышенного внимания.

4.8 Нежелательные реакции

Резюме профиля безопасности

Очень частыми нежелательными реакциями (>1/10) в клинических исследованиях были тошнота, сухость во рту, головная боль и потливость (в том числе, ночная потливость).

Резюме нежелательных реакций

Нежелательные реакции представлены ниже в виде распределения по системно-органным классам, с указанием частоты их возникновения и в порядке уменьшения их серьезности внутри каждой категории.

Частота определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥ 1/100, но <1/10), нечасто (≥ 1/1 000, но <1/100), редко (≥ 1/10 000, но <1/1 000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:

Редко: агранулоцитоз*, апластическая анемия*, нейтропения*, панцитопения*.

Очень редко: тромбоцитопения;

Нарушения со стороны иммунной системы:

Редко*:* анафилактическая реакция*.

Эндокринные нарушения:

Редко: синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНС АДГ)*;

Очень редко*:* повышение концентрации пролактина в плазме крови*.

Нарушения метаболизма и питания:

Часто: снижение аппетита;

Редко: гипонатриемия*.

Психические нарушения:

Очень часто: бессонница;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Часто: спутанное состояние сознания*, деперсонализация*, необычные сновидения, нервозность, снижение либидо, возбуждение*, аноргазмия;

Нечасто: мания, гипомания, галлюцинации, дереализация, нарушение оргазма, бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами)*; апатия;

Редко: делирий*;

Частота неизвестна: суицидальные мысли и поведение, агрессия[б].

Нарушения со стороны нервной системы:

Очень часто: головная боль*[в], головокружение, седация;

Часто: акатизия*, тремор, парестезия, дисгевзия;

Нечасто: синкопе, миоклонус, нарушение координации*, нарушение равновесия*, дискинезия*;

Редко: злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)*, серотониновый синдром*, судороги, дистония*;

Очень редко: поздняя дискинезия.

Нарушения со стороны органа зрения:

Часто: нарушение зрения, нарушение аккомодации, включая нечеткость зрения, мидриаз;

Редко*:* закрытоугольная глаукома*.

Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта:

Часто: шум в ушах*;

Частота неизвестна: вертиго.

Нарушения со стороны сердца:

Часто: тахикардия, ощущение сильного сердцебиения*;

Редко: полиморфная желудочковая тахикардия типа «пируэт»*, желудочковая тахикардия*, фибрилляция желудочков, удлинение интервала QT на ЭКГ*;

Частота неизвестна*:* стрессовая кардиомиопатия (кардиомиопатия такоцубо)*.

Нарушения со стороны сосудов:

Часто: артериальная гипертензия, «приливы» ;

Нечасто: ортостатическая гипотензия, гипотензия*.

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:

Часто: одышка*, зевота;

Редко*:* интерстициальная болезнь легких*, легочная эозинофилия*.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:

Очень часто: тошнота, сухость слизистой оболочки полости рта, запор;

Часто*:* диарея*, рвота;

Нечасто: желудочно-кишечное кровотечение*;
Редко: панкреатит*.

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:

Нечасто: изменение активности печеночных ферментов*;

Редко: гепатит*.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:

Очень часто: потливость* (в том числе ночная)*;

Часто: сыпь, кожный зуд;

Нечасто: крапивница*, алопеция*,экхимоз, ангионевротический отек*, реакции фоточувствительности;

Редко: синдром Стивенса-Джонсона*, токсический эпидермальный некролиз*, многоформная эритема*.

Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани:

Часто: гипертонус;

Редко: рабдомиолиз*.

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:

Часто: нарушение мочеиспускания (преимущественно затрудненное начало мочеиспускания), задержка мочи, поллакиурия*;

Нечасто*:* недержание мочи*.

Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез:

Часто: менорраргия*, метроррагия*, эректильная дисфункция[б], нарушения эякуляции[б];

Частота неизвестна: послеродовое кровотечение[г].

Общие нарушения и реакции в месте введения:

Часто: усталость, астения, озноб*;

Очень редко: кровоизлияние в слизистые оболочки*.

Лабораторные и инструментальные данные:

Часто: снижение массы тела, увеличение массы тела, повышение концентрации холестерина в крови;

Очень редко: увеличение продолжительности кровотечения.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

* Нежелательная реакция выявлена в пострегистрационном периоде.
[а] Зарегистрированы случаи суицидальных мыслей и суицидального поведения во время лечения венлафаксином и вскоре после прекращения лечения (см. 4.4).
[б] См. раздел 4.4
[в] По обобщенным результатам клинических исследований, частота головной боли в группах пациентов, получавших венлафаксин и плацебо не отличались.
[г] Данная реакция наблюдалась для класса препаратов СИОЗС/СИОЗСН (см. разделы 4.4 и 4.6).

Отмена лечения

Прекращение (особенно резкое) приема венлафаксина часто ведет к синдрому отмены. Головокружение, нарушение чувственного восприятия (в том числе парестезия), нарушения сна (в том числе бессонница и яркие сновидения), психомоторное возбуждение или тревога, тошнота и/или рвота, тремор, вертиго, головная боль, гриппоподобный синдром, нарушение зрения и гипертензия - наиболее частые реакции. В основном эти явления слабовыраженные и проходят самостоятельно, тем не менее, у некоторых пациентов они могут быть тяжелыми и/или длительными. Поэтому рекомендуется, когда лечение венлафаксином больше не требуется, прекращать прием препарата постепенно, медленно снижая его дозу. Тем не менее, у некоторых пациентов после понижения дозы или прекращения лечения наблюдалась выраженная агрессия и суицидальные мысли (см. 4.2 и 4.4).

Дети

В целом, профиль неблагоприятных реакций венлафаксина (в плацебо-контролируемом клиническом исследовании) у детей и подростков (в возрасте от 6 - 17 лет) был схож с профилем у взрослых. Как и у взрослых наблюдались снижение аппетита, снижение массы тела, повышенное артериальное давление и повышенный уровень холестерина в сыворотке крови (см. 4.4).

В педиатрических клинических исследованиях наблюдалась нежелательная реакция - суицидальные мысли. Также зарегистрировано увеличение случаев враждебности и, особенно при большом депрессивном расстройстве, самоповреждения.

В частности, у детей наблюдались следующие нежелательные реакции: боль в животе, психомоторное возбуждение, диспепсия, экхимоз, носовое кровотечение и миалгия.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13

Телефон: +7 (7172) 235–135

Электронная почта: farm@dari.kz

Сайт: http://www.ndda.kz

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: http://www.rceth.by

Республика Армения

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am

Сайт: http://www.pharm.am

4.9 Передозировка

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Симптомы

В пострегистрационном периоде зарегистрированы случаи передозировки венлафаксином, преимущественно в комбинации с алкоголем и/или другими лекарственными препаратами, включая случаи с летальным исходом. К наиболее частым явлениям при передозировке относятся: тахикардия, изменение уровня сознания (от сонливости до комы), мидриаз, судороги и рвота. К другим зарегистрированным явлениям относятся изменения ЭКГ (например, удлинение интервала QT, блокада ножки пучка Гиса, расширение комплекса QRS (см. раздел 5.1)), желудочковая тахикардия, брадикардия, гипотензия, гипогликемия, вертиго и смерть.

После приема примерно 3 г венлафаксина у взрослых пациентов могут возникнуть симптомы тяжелого отравления.

В опубликованных ретроспективных исследованиях сообщается, что передозировка венлафаксином может быть связана с более высоким риском летальных исходов в сравнении с антидепрессантами СИОЗС, но ниже, чем для трициклических антидепрессантов. Эпидемиологические исследования показали, что риск суицида у пациентов, получавших лечение венлафаксином выше, чем у пациентов, получавших лечение СИОЗС. Неясно, в какой степени выявленный повышенный риск летальных исходов может быть связан с токсичностью венлафаксина при передозировке, в противопоставление некоторым характеристикам пациентов, получавших лечение венлафаксином.

Лечение

Тяжелое отравление может потребовать комплексного неотложного лечения и наблюдения. В случае подозрения на передозировку венлафаксином, следует немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Рекомендуется общие поддерживающие и симптоматические меры, непрерывный контроль жизненно важных функций (дыхания и кровообращения). При наличии риска аспирации не рекомендуется вызывать рвоту. Если после передозировки прошло немного времени или при наличии симптомов передозировки у пациентов, может быть показано промывание желудка. Назначение активированного угля может снизить всасывания препарата. Промывание желудка показано, если проводится вскоре после проглатывания, или у пациентов с соответствующими симптомами. Не рекомендуется вызывать рвоту в связи с опасностью аспирации. Форсированный диурез, диализ, перфузия крови и обменное переливание крови мало полезны. Специфический антидот к венлафаксину неизвестен.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

5 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: психоаналептики, антидепрессанты, другие антидепрессанты.

Код АТХ: N06AX16

Механизм действия, фармакодинамические эффекты

Венлафаксин - антидепрессант. По химической структуре его нельзя отнести ни к одному известному классу антидепрессантов (трициклические, тетрациклические или другие). Он имеет две активные энантиомерные рацемические формы.

Антидепрессивный эффект венлафаксина связан с усилением нейротрансмиттерной активности в ЦНС. Венлафаксин и его основной метаболит ОДВ являются мощными СИОЗСН и слабо подавляют обратный захват дофамина нейронами. Венлафаксин и ОДВ одинаково эффективно влияют на обратный захват нейротрансмиттеров. Венлафаксин и ОДВ снижают бета-адренергические реакции.

Венлафаксин не обладает сродством к мускариновым, холинергическим, гистаминовым (H1) и a_1-адренергическим рецепторам головного мозга. Венлафаксин не подавляет активность МАО. Не обладает сродством к опиатным, бензодиазепиновым, фенциклидиновым или М-метил-d-аспартатным (NMDA) рецепторам.

5.2 Фармакокинетические свойства

Абсорбция

При однократном приеме внутрь всасывается не менее 92% дозы венлафаксина. Абсолютная биодоступность венлафаксина составляет от 40% до 45%. После приема внутрь C_{max} венлафаксина и ОДВ в плазме крови достигаются через 2 и 3 часа соответственно. После приема венлафаксина в форме капсул с пролонгированным высвобождением C_{max} венлафаксина и ОДВ в плазме крови достигались через 5,5 и 9 часов соответственно. При приеме венлафаксина в равных суточных дозах в форме таблеток с немедленным высвобождением или капсул с пролонгированным высвобождением капсулы с пролонгированным высвобождением обеспечивают более медленную скорость всасывания, но такую же ее степень, как и при приеме в форме таблеток с немедленным высвобождением.

Равновесные концентрации венлафаксина и ОДВ достигаются в течение 3 дней после начала пероральной терапии с многократным приемом препарата.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Прием пищи не влияет на биодоступность венлафаксина и ОДВ.

Распределение

Венлафаксин и ОДВ в терапевтических концентрациях в минимальной степени связываются с белками плазмы крови (27% и 30% соответственно). Объем распределения венлафаксина в равновесном состоянии после внутривенного введения составляет 4,4 ± 1,6 л/кг.

Биотрансформация

Венлафаксин активно метаболизируется, прежде всего, до активного метаболита ОДВ. Венлафаксин преимущественно метаболизируется в печени при участии изофермента CYP2D6 до образования основного активного метаболита ОДВ и при участии изофермента CYP3A4 - до второстепенного, менее активного, метаболита до N-десметилвенлафаксина. Результаты исследований *in vivo* показывают, что венлафаксин является относительно слабым ингибитором изофермента CYP2D6 и не ингибировал изоферменты CYP1A2, CYP2C9 или CYP3A4.

Элиминация

Венлафаксин и его метаболиты выводятся преимущественно почками. Приблизительно 87% принятой внутрь дозы венлафаксина обнаруживаются в моче в течение 48 часов в неизмененном виде, в виде неконъюгированного ОДВ, конъюгированного ОДВ и других второстепенных неактивных метаболитов. Среднее значение ± стандартное отклонение клиренса венлафаксина и ОДВ из плазмы крови в равновесном состоянии составляет 1,3 ± 0,6 л/ч/кг и 0,4 ± 0,2 л/ч/кг соответственно.

Средний $T_{1/2}$ венлафаксина и ОДВ из плазмы крови составляет 5 ± 2 и 11 ± 2 часов соответственно

Линейность/нелинейность

Венлафаксин и ОДВ демонстрируют линейную кинетику в диапазоне доз от 75 до 450 мг. в сутки.

Особые группы пациентов

Возраст и пол

Пол и возраст пациентов не оказывают существенного влияния на фармакокинетику венлафаксина и ОДВ.

Пациенты с быстрым/медленным метаболизмом изофермента CYP2D6

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Концентрация венлафаксина в плазме крови у медленных метаболизаторов изофермента CYP2D6 выше, чем у быстрых метаболизаторов. Поскольку общая экспозиция (AUC) венлафаксина и ОДВ одинакова у медленных и быстрых метаболизаторов, нет необходимости в разных схемах дозирования венлафаксина в этих двух группах.

Печеночная недостаточность

У пациентов, относящихся к классу А (нарушение функции печени легкой степени) и классу В (нарушение функции печени средней степени) по классификации Чайлда-Пью, $T_{1/2}$ венлафаксина и ОДВ был более длительным, по сравнению с таковым у здоровых лиц. Клиренс венлафаксина и ОДВ после приема внутрь был снижен. Была отмечена значительная степень межиндивидуальной вариабельности. Имеются ограниченные данные у пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени (см. раздел 4.2).

Почечная недостаточность

У пациентов, находящихся на диализе, T½ венлафаксина был продлен примерно на 180%, а его клиренс уменьшен примерно на 57%, по сравнению со здоровыми лицами, тогда как T½ ОДВ был продлен примерно на 142%, а его клиренс уменьшен примерно на 56%. Коррекция дозы необходима пациентам с нарушением функции почек тяжелой степени и у пациентов, которым требуется гемодиализ (см. раздел 4.2).

5.3 Данные доклинической безопасности

Данные отсутствуют.

6 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1 Перечень вспомогательных веществ

Целлюлоза микрокристаллическая

Натрия хлорид

Диметикон (Е-1049 39 %)

Камедь ксантановая

Калия хлорид

Кремния диоксид коллоидный безводный

Тальк

Оболочка:

Этилцеллюлоза

Коповидон

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Тальк

Краситель железа оксид желтый (Е172)

Состав желатиновой капсулы:

Титана диоксид (Е171)

Краситель железа оксид желтый (Е172)

Краситель железа оксид красный (Е172)

Желатин

6.2 Несовместимость

Не применимо.

6.3 Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

6.5 Характер и содержание упаковки

Капсулы с пролонгированным высвобождением, 75 мг, 150 мг.

По 10 или 14 капсул в блистере из поливинилхлорид/поливинилиденхлорид // алюминиевой фольги. 2 или 6 блистеров по 14 капсул или 3 блистера по 10 капсул вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

6 блистеров по 14 капсул доступны только в Российской Федерации.

6.6 Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7 ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Венгрия

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

1106 Будапешт, ул. Керестури, 30-38

Телефон: (+36-1) 803-5555

Электронная почта: mailbox@egis.hu

7.1 Представитель держателя регистрационного удостоверения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация

ООО «ЭГИС-РУС»

121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д.19, этаж 13 блок В.

Телефон: +7 (495) 363-39-66

Электронная почта: pharmacovigilance@egis.ru

Республика Казахстан

Представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» в Республике Казахстан

050060, г. Алматы, ул. Жарокова 286 Г.

Телефон: + 7 (727) 247 63 34, + 7 (727) 247 63 33, +7(771) 929 25 25

Электронная почта: egis@egis.kz

Республика Беларусь

Представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия) в Республике Беларусь

220053, г. Минск, пер. Ермака, д. 6А.

Телефон: (017) 380-00-80, (017) 227-35-51, (017) 227-35-52.

Факс: (017) 227-35-53.

Электронная почта: info@egis.by

Республика Армения

Представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» в Республике Армения

0010, г. Ереван, ул. Анрапетутян, дом 67, 4 этаж.

Телефон: +374–10 574509

Электронная почта: info@egis.am

8 НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЛП-№(002093)-(РГ-RU)

9 КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

10 ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

Общая характеристика лекарственного препарата Велаксин доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).

V_0019